SYNDROME CORDONAL POSTERIEUR

DR R.CHENNA

INTRODUCTION

- L’ensemble des signes et symptômes traduisant une atteinte du cordon postérieure de la moelle épinière.

- Il fait partie des syndromes sensitifs centraux.

RAPPEL ANATOMOPHYSIOLOGIQUE :

- ME est un prolongement de l'encéphale,
- Siège au niveau du canal rachidien
- Aspect de cylindre, s'étend de C1 à L1- L2
- Se continue par un filum terminal.
- La moelle se termine par le cône terminal et la

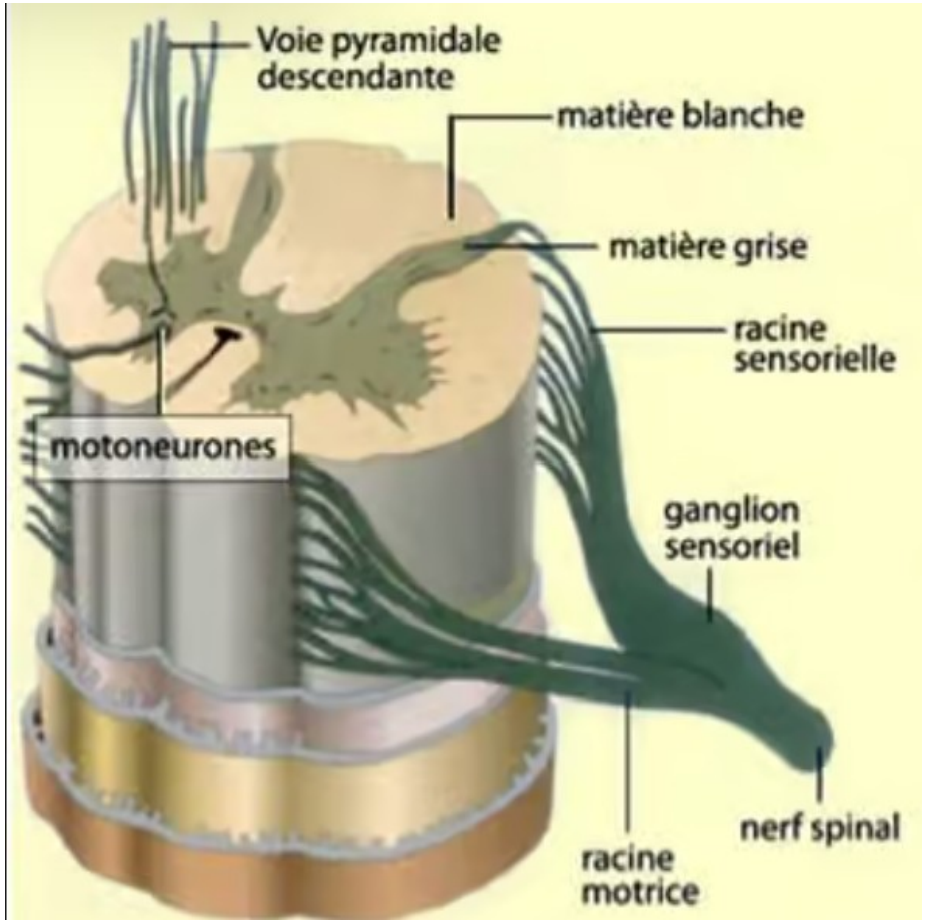
queue de cheval constituer par les dernières racines rachidiennes qui sortent de la moelle lombaire et sacré

- Constituée d'un axe de substance grise autour du

canal ependymaire

- Cet axe de SG est entouré de cordons de substance blanche

formés par les grandes voies longues du SNC

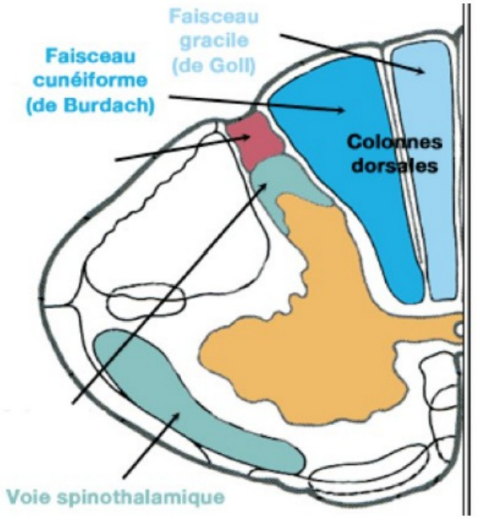


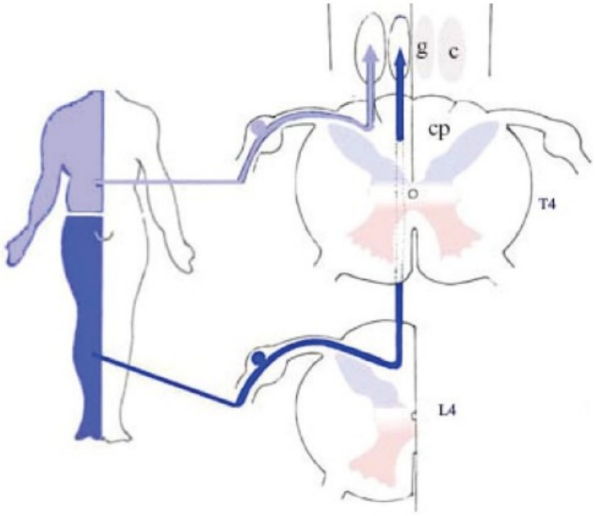
RAPPEL ANATOMOPHYSIOLOGIQUE :

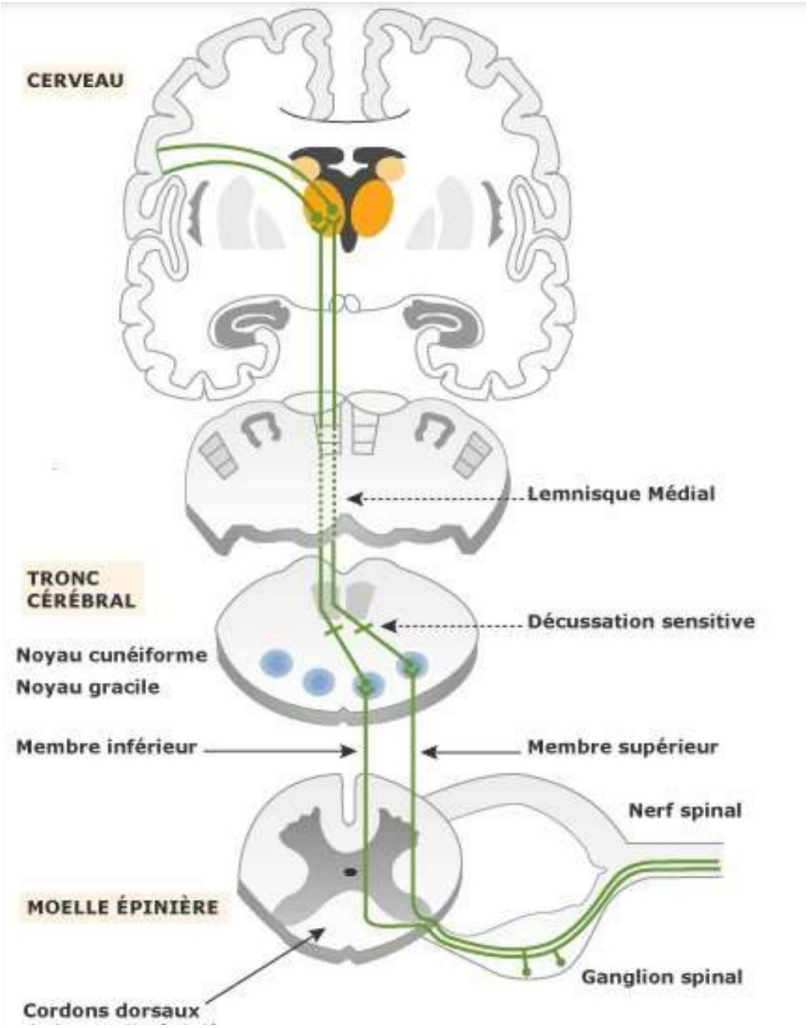
- le système lemniscal véhicule

– la sensibilité profonde

– et la sensibilité tactile épicritique







SEMIOLOGIE

- **Troubles sensitifs profondes subjectifs**

- paresthésie : sensation de fourmillements, de picotements, de peau cartonnée ou rétrécie, impression de marcher sur du caoutchouc.

Ces paresthésies ont souvent un territoire étendu, bilatéral et plus ou moins asymétrique.



- **Douleurs fulgurantes:** il peut s'agir de douleurs vives dites fulgurantes, en éclair, survenant par crises de quelques minutes à quelques heures ou térébrantes à type de morsure profonde en un point fixe.

- **Signe de Lhermitte:** sensation de décharge électrique parcourant de haut en bas le rachis et les membres lors de la flexion de la tète.

SEMIOLOGIE

- **Troubles de la sensibilité profonde élémentaires**

1) L'ataxie proprioceptive

troubles du maintien des attitudes : Dans la station debout, les talons rapprochés, le malade présente des oscillations. Si on lui demande de fermer les yeux, les troubles s'accentues et le sujet risquerait de tomber si on ne le retenait **(Signe de Romberg).**

troubles des mouvements :

La Démarche tâlonnante: la marche est également perturbée en raison de l'ataxie des membres inferieurs, La jambe est lancée plus haut que nécessaire et retombe brutalement sur le talon.

SEMIOLOGIE

2) Perturbation du sens de position de segment

Le patient ne peut indiqué les yeux fermes la position du membre atteint,

Elle est au mieux étudiée au niveau des extrémités par la mobilisation d'un doigt (l'index) ou d'un orteil (le gros orteil), dont on demande au sujet d'identifier la position ou le sens d'un mouvement lent **(La sensibilité arthrokinétique)**



SEMIOLOGIE

3) La sensibilité vibratoire (la pallesthésie):

elle s'explore par l'utilisation d'un diapason de fréquence lente (environ 100 HZ) appliqué sur les tubérosités osseuses (styloïdes, olécrane, clavicule, crêtes iliaques, rotule, crête tibiale, malléoles).



SEMIOLOGIE

4) Baresthesie: c'est la perte de la sensibilité à la pression, aux différences de

Poids, s'apprecie en utilisant des objets de poids varié, que l'on place sur la peau.

5) La graphesthésie est la capacité d'identifier les lettres ou les chiffres tracés sur

le revêtement cutané.

6) L'astéréognosie est une perte de la reconnaissance des objets par la palpation (elle peut être secondaire à des troubles des sensibilités élémentaires)

L'ESSENTIEL A RETENIR

- **Comporte une riche sémiologie faite**

Des paresthésies

Signe de Lhermitte

- **A l’examen :**

– ce sont les troubles de la sensibilité discriminative, en particulier de la pallesthésie et la kinesthésie, qui sont au premier plan.

– Une ataxie avec un signe de Romberg à la station debout.

– Astéréognosie.